

通報 日期：中華民國110年11月9日

單位：緊急救護科

承辦人：朱英綺

電話：(02)89519119 分機6422

附件：

一、鑑於日前外縣市執行緊急救護現場死亡案件時，現場救護同仁針對屍僵個案，易生誤判及不易辨識情形，本局為求謹慎及避免衍生爭訟，經邀集各大隊及醫療指導醫師討論共識，爰修正相關處理流程送醫標準，並另案同步修正本局緊急傷病患救護作業流程（MI無脈搏）。

二、有關前揭修正內容如下：

（一）現場死亡定義：「人體達到屍腐、屍僵、屍體焦黑、無首、內臟外溢或軀幹斷肢的狀態之一者，且無意識、無呼吸、無脈搏之情形」。

（二）處置原則：救護同仁判定傷病患為現場死亡後，應立即向家屬說明，並回報救災救護指揮中心，由中心通知轄區警察到場執行行政相驗或司法相驗，倘需送醫仍應依本局緊急傷病患救護作業程序之心肺功能停止流程進行急救，並儘速送醫。

（三）下列情形可不施行心肺復甦術：

1、現場死亡（除屍僵外）。屍僵處理流程第一時間應予以CPR及使用AED監測，並向家屬說明評估結果，倘家屬（關係人）表達送醫需求或現場無家屬，則應按心肺功能停止流程進行急救，並儘速送醫。

2、傷病患本身或現場有致命性危害因素尚未排除前（前項阻卻施行心肺復甦術之因素排除或情況改變時，仍應恢復施行）。

3、遇大量或嚴重傷病患救護，依檢傷分類尚有其他較優先傷病患待救時（前項阻卻施行心肺復甦術之因素排除或情況改變時，仍應恢復施行）。

4、傷病患係重病末期，且本身事先已預立「不施行心肺復甦術意願書」或「選擇安寧緩和醫療意願書」，家屬出示前揭意願書並於救護紀錄表簽名表示「拒絕任何處置」。

三、緊急救護辦法第14條規定，「救護人員執行救護應填具救護紀錄表，於送抵急救醫院時，應由醫護人員簽章確認紀錄表所載事項」，不論患者是否送醫皆應紀錄患者資料、生命徵象、處置項目及其他補述紀錄等，以利查閱。

四、請各大隊利用各式集會（訓練）時機，轉知所屬同仁知悉。

此致

各救災救護大隊